Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Bom

Avenida dos Estados, 800 - Bairro: Vinte e Cinco de Julho - CEP: 93700000 - Fone: (51) 3098 3398 - Email: frcampobom2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000399-46.2022.8.21.0087/RS

AUTOR: SIMONE GRIFANTE REIS SMANIOTTO

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

SIMONE GRIFANTE REIS SMANIOTTO ajuizou a presente *ação ordinária com pedido de tutela antecipada* contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**. Nos dizeres da inicial, relatou que é diagnosticada com DOENÇA DE CROHN, catalogada sob o CID 10 K50.0, necessitando com urgência do medicamento USTEQUINUMABE 130 mg, na quantidade de 3 (três) ampolas, em dose única, e a partir de 8 semanas, a utilização contínua de USTEQUINUMABE 90 mg, na quantidade de 1 (uma) ampola a cada dois (dois) meses, por tempo indeterminado, sob pena de progressão da doença gastrointestinal, aumento de morbimortalidade, agravo de fístulas, infecções intestinais e perfurações intestinais. Juntou laudo médico (evento 1, LAUDO8), receituário (evento 1, RECEIT9), negativa do fornecimento do medicamento (evento 1, OUT10) e comprovação de que o medicamento é registrado pela ANVISA (evento 1, OUT12). Pediu pela concessão da antecipação da tutela para que o réu fosse compelido a fornecer a medicação de que necessita, sob pena de bloqueio de valores.

Recebida a inicial, foi deferia a liminar e intimado o réu para fornecer a medicação no prazo de 10 (dez) dias (evento 3, DESPADEC1).

Noticiado o descumprimento da liminar a autora pediu o bloqueio de R$ 113.562,00 (treze mil quinhentos e sessenta e dois reais) para aquisição dos medicamentos relativo a 04 (quatro) meses de aplicação (evento 9, PET1).

Houve dispensação na rede pública do medicamento USTEQUINUMABE 130MG (evento 11, INF1).

O réu apresentou contestação, preliminarmente pediu pela aplicação do Tema 793 do STF com a necessidade de redirecionamento do feito à União, no mérito pediu pela improcedência do pedido, e, subsidiariamente, para o caso de julgamento de procedência, seja determinado o fornecimento do medicamento pela Denominação Comum Brasileira, conforme determina o artigo 3º da Lei nº 9.787/99 (Lei do Medicamento Genérico), condicionando o fornecimento do fármaco à apresentação semestral pela parte autora de receituário médico atualizado, pediu que a autora fosse intimada a apresentar laudo médico fundamentado acerca da possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por alternativas disponíveis no SUS (evento 12, CONT1).

A autora noticiou novamente o descumprimento da liminar, pediu o bloqueio de R$ 36.120,00 (trinta e seis mil cento e vinte reais) para aquisição de 01 (uma) dose de aplicação do medicamento USTEQUINUMABE 90 mg, juntou orçamentos (evento 14, PET1).

Houve réplica (evento 16, RÉPLICA1).

Houve dispensação na rede pública do medicamento USTEQUINUMABE 90 mg (evento 19, INF1 e evento 20, INF1).

A decisão saneadora afastou preliminares arguidas em contestação e intimou as partes para que declinassem as provas a produzir (evento 21, DESPADEC1).

O Estado do Rio Grande do Sul reiterou o item "d" dos requerimentos formulados em contestação (evento 27, PET1), pedido já indeferido pelo juízo (evento 21).

A autora dispensou a produção de outras provas (evento 28, PET1).

Durante a instrução, houve pedido de bloqueio de valores para a aquisição dos medicamentos de forma particular (eventos 24, 53, 75, 101), os quais foram deferidos pelo juízo (eventos 33, 55, 80, 103), tendo a parte autora prestado contas e devolvido valores remanescentes (eventos 52, 74, 100, 119).

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela procedência do pedido e conformação da antecipação da tutela concedida (evento 108, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

O feito transcorreu normalmente e não há nulidades.

Passo a análise do mérito.

1. Fundamentação:

O direito à saúde, de natureza fundamental (art. 6º da CF/88), é garantido mediante *(i.)* a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e *(ii.)* o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF/88).

Para a realização deste direito, determinou o art. 198 da CF/88 a formação de uma rede regionalizada e hierarquizada em um sistema único e descentralizado – Sistema Único de Saúde (SUS) -, cujas diretrizes são as seguintes:

> *"I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;*
>
> *II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;*
>
> *III - participação da comunidade."*

<u>A diretriz do atendimento integral para a saúde compreende, evidentemente, a assistência farmacêutica.</u>

Por se tratar de uma obrigação comum dos entes federados (art. 23, II, c/c art. 196 da CF/88), a realização do direito à saúde é disciplinada por leis e regulamentos administrativos, que discriminam a competência de cada um dos entes da Federação.

O Supremo Tribunal Federal decidiu a questão em dois temas com repercussão geral, a saber, o de nº 500 e o de nº 793, que afirmaram as seguintes teses:

> *"Tema 500: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.*
>
> *Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."*

Logo, tem-se que:

> *a) persiste a solidariedade no atendimento do direito à saúde;*
>
> *b) em princípio, deve-se atentar para a ordenação administrativa do SUS;*
>
> *c) a falta de fármaco nas listas de dispensação pode ser suprida no caso de omissão injustificada da Administração Pública, vedando-se os fármacos sem registro e importados ou procedimentos clínicos e cirúrgicos de caráter experimental (art. 19-T da Lei nº 8.080/90).*

Todavia, da leitura do acórdão dos EdCl no RE nº 855.178/SE, que gerou a edição da súmula do Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a tese realmente firmada por maioria foi a sustentada pelo Min. Edson Fachin, o qual, em seu voto, firmou as seguintes conclusões:

> *"i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);*
>
> *ii) Afirmar que "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente" significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ;*
>
> *iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;*
>
> *iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ;*
>
> *v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19- Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;*
>
> *vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11."*

De acordo com estas conclusões, pode-se afirmar, então, que o conceito de solidariedade, até então adotado, foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, de acordo com as regras acerca da divisão de competências e conforme determinado pelo item "V" do voto condutor acima transcrito, por se tratar de serviço não disponibilizados pelo SUS, seria devida a inclusão da União Federal no polo passivo, pois a ela compete a inclusão ou não de itens nas políticas públicas do SUS.

Entretanto, recentemente, os Tribunais Superiores publicaram decisões envolvendo o fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos de saúde, padronizados ou não pelo SUS, e a aplicação da tese fixada no Tema 793 do STF e respectivos aclaratórios.

Com efeito, importa destacar a decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema 1234/STF, proferida em 17/04/2023, deferindo parcialmente o pedido incidental de tutela provisória no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234), nos seguintes termos:

> *"(i) **nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados**: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;*
>
> *(ii) **nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:** devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;*
>
> *(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos **sem sentença prolatada**; diferentemente, os processos **com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023)** devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*
>
> *(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".*

Friso que **a decisão supramencionada foi referendada pelo Plenário do STF**, na sessão virtual extraordinária de 18/04/2023, cujo acordão foi publicado em 25/04/2023, restando a ementa assim redigida:

> *REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.*
> *1. **O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.***
> *2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.*
> *3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.*
> *4. **No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.***
> *5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.*
> ***6. Tutela provisória referendada.***
> *(RE 1366243 TPI-Ref, **Relator(a): GILMAR MENDES**, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) (grifei)*

Consigno, também. que **a suspensão nacional,** até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234), **atingiu apenas o processamento dos recursos especiais e extraordinários** que tratam da questão controvertida no Tema 1234 do STF, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.

Logo, por se tratar de demanda judicial relativa a tratamentos não incorporados, deve ser processada e julgada pelo juízo estadual (juízo direcionado pela parte autora), pois vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral.

No caso dos autos, os fármacos descritos na iniciam não constam das listas públicas de fármacos disponibilizados no SUS[1].

A necessidade de fornecimento do fármaco está comprovada pelo laudo anexo ao evento 1 dos autos (evento 1, LAUDO8).

Ainda, esclareço que o STJ, ao julgar o Tema 106, definiu os requisitos para fornecimento de medicamentos não constantes da listagem do SUS, modulando os efeitos, no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.

Nesse sentido a decisão do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, sendo Relator o Ministro Benedito Gonçalves, publicado no dia 04 de maio de 2018, referente ao TEMA 106 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte ementa:

> *"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.*
>
> *1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.*
>
> *2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.*
>
> *3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.*
>
> *4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*
>
> *5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."*

Isto é, conforme o julgamento, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

> *(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> *(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> *(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*

No caso dos autos, é certo que estes requisitos foram provados, pois *(i.)* há laudo médico que demonstra a imprescindibilidade e necessidade de fornecimento das medicações (evento 1, LAUDO8), *(ii.)* a incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento também é demonstrada pelos documentos juntados na inicial (evento 1, CTPS7), e *(iii.)* os medicamentos estão registrados na ANVISA (evento 1, OUT12).

Assim, a procedência da ação é medida que se impõe, confirmando-se a liminar que determinou ao réu o fornecimento dos fármacos.

2. Dispositivo:

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, para condenar o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** a fornecer em favor de **SIMONE GRIFANTE REIS SMANIOTTO**, os medicamentos *(i.)* USTEQUINUMABE 130 mg, na quantidade de 3 (três) ampolas, em dose única e *(ii.)* USTEQUINUMABE 90 mg, na quantidade de 1 (uma) ampola a cada dois (dois) meses, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a necessidade, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela (evento 03).

Os medicamentos deverão ser fornecidos à autora enquanto perdurar a necessidade, conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB). Saliento que incumbirá à parte autora atualizar seu receituário médico nas farmácias públicas a cada 6 (seis) meses.

Custas pelo Estado, ficando isento da Taxa Única de Serviços Judiciais conforme a previsão do artigo 5º, inciso I, da Lei Estadual nº 14.634/2014, mas respondendo por eventuais despesas do processo pendentes.

Condeno o demandado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na forma do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil, já que estava obrigado ao fornecimento do tratamento e houve a negativa administrativa. Em consonância com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic, a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Caso interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades dos §§ 1º e 2º, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo necessidade de novo bloqueio de valores para aquisição do medicamento, enquanto não ocorrer trânsito em julgado desta decisão, deverá ser distribuído em apartado como "Cumprimento provisório de sentença".

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALVARO WALMRATH BISCHOFF, Juiz de Direito**, em 12/12/2023, às 16:19:2, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10049649908v16** e o código CRC **6a483dbd**.

---

1. https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/relacao-nacional-de-medicamentos-essenciais ↩